TUBE DIGESTIF · DI-01

Cancer du rectum · IRM (ESGAR 2026)

ESGAR 2026 (Eur Radiol)
bilan initial · protocole, cT, MRF, EMVI, cN

PROTOCOLE IRM (BILAN INITIAL)

Séquences

- **T2 haute résolution** obligatoire : coupes **≤ 3 mm**, résolution dans le plan **< 1 × 1 mm** ; plan **perpendiculaire** à la tumeur (oblique axial), sagittal ; coronal oblique pour les tumeurs basses
- Au moins une séquence **grand champ** T2 ou T1 de la bifurcation aortique au canal anal (ganglions inguinaux inclus)
- **Diffusion** dans le même plan que le T2 oblique axial : lecture visuelle, sans seuil d'ADC
- **Injection dynamique non recommandée** en routine

Préparation

- **Pas de remplissage rectal** pour le bilan initial
- Micro-lavement : optionnel au bilan initial, **recommandé pour la réévaluation** (moins d'artefacts en diffusion)
- Antispasmodique : sans consensus, utile pour les tumeurs hautes
- Tumeurs précoces (T1) : écho-endoscopie rectale préférable à l'IRM

LOCALISATION · STADE T

Rectum ou sigmoïde ?

- **Charnière recto-sigmoïdienne** (« sigmoid take-off ») : point où le sigmoïde quitte le sacrum horizontalement en sagittal, vers l'avant en axial
- Cancer du rectum si le bord inférieur est **au niveau ou sous** cette charnière
- Hauteur : lignes droites depuis la **jonction anorectale** ou la **marge anale** (repère à préciser et à garder constant ; écart de 3–5 cm)

Stade cT

cT1–T2	Limité à la paroi (sous-muqueuse, musculeuse)
cT3a–d	Extension dans le mésorectum : a < 1 mm · b 1–5 mm · c 5–15 mm · d > 15 mm
cT4a	Péritoine viscéral
cT4b	Organe ou structure adjacente, dont **sphincter externe, puborectal, releveurs**

Tumeurs basses : stadifier au niveau du rectum ; l'atteinte du sphincter interne ou de l'espace intersphinctérien ne compte pas pour le cT ; ajouter « **anal+** » en conclusion.

FASCIA MÉSORECTAL (MRF) ET EMVI

MRF envahi si marge ≤ 1 mm

- Par extension tumorale directe
- Par **EMVI** (invasion veineuse extramurale)
- Par un nodule irrégulier : dépôt tumoral ou ganglion avec effraction capsulaire
- La catégorie « MRF menacé 1–2 mm » est **abandonnée**
- Un ganglion à contours lisses à ≤ 1 mm n'envahit pas le MRF

EMVI et dépôts tumoraux

- EMVI : signal tumoral dans une veine extramurale, veine élargie, contours irréguliers
- Dépôts tumoraux : nodules le long des veines, discontinus de la tumeur, sans forme ni capsule ganglionnaires
- Pour le cN, regrouper ganglions et dépôts suspects (TNM 8) ; décrire les dépôts à part

GANGLIONS

Mésorectaux · approche 2026

- Évaluation **globale par patient**, avec niveau de confiance : cN0 | cN+ possible | cN+
- Arguments : cT avancé, EMVI, nombre de ganglions suspects
- Repères morphologiques (ESGAR 2016/2018) : ≥ 9 mm ; 5–8 mm avec ≥ 2 critères ; < 5 mm avec 3 critères (forme ronde, contours irréguliers, signal hétérogène) ; tout ganglion mucineux

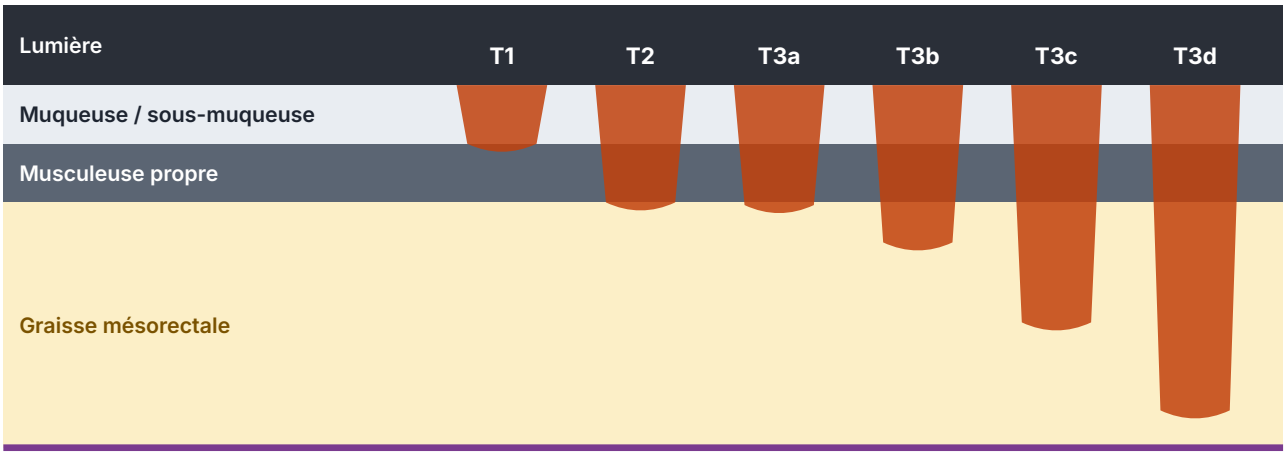
Latéraux (obturateurs, iliaques internes)

- Malin si petit axe **≥ 7 mm**
- 5–7 mm : critères morphologiques (preuves limitées)
- La diffusion aide à repérer les ganglions, pas à les caractériser
- Iliaques externes, inguinaux : à décrire séparément (classés M1 en TNM 8)

Cancer du rectum · IRM (ESGAR 2026) (suite)

ATLAS VISUEL

Paroi rectale, mésorectum et stade T (coupe perpendiculaire)



Fascia mésorectal (MRF) : envahi si marge ≤ 1 mm

T3 : a < 1 mm · b 1–5 mm · c 5–15 mm · d > 15 mm au-delà de la musculeuse
T4a : péritoine viscéral · T4b : organe voisin, sphincter externe, releveurs

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Stadification du cancer du rectum
Radiopaedia · T, N, MRF
radiopaedia.org/articles/rectal-cancer-staging?l

IRM rectale : démarche
Radiopaedia · lecture pas à pas
radiopaedia.org/articles/rectal-mri-an-approach

Protocole IRM rectum
Radiopaedia · plans et séquences
radiopaedia.org/articles/rectal-cancer-protocol-

Invasion veineuse extramurale (EMVI)
Radiopaedia · grades
radiopaedia.org/articles/extramural-vascular-inv

Fascia mésorectal
Radiopaedia · anatomie
radiopaedia.org/articles/mesorectal-fascia

Sources : ESGAR 2026 – MRI to guide management of rectal cancer, part I – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-12274-w · Critères ganglionnaires ESGAR 2016/2018 (synthèse) – link.springer.com/article/10.1007/s00384-025-04984-w